

Anamnèse approfondie

Profil neuro-atypique — Adolescent

TND · Dys · TSA · Émotions · Psychologie

■ ■ Ce questionnaire est un outil de repérage clinique approfondi. Il ne pose pas de diagnostic. Les résultats doivent être croisés avec l'histoire développementale, les bilans disponibles, les observations cliniques et les données contextuelles. Un signe isolé n'est jamais suffisant.

Contexte clinique de ce questionnaire

Ce questionnaire est conçu pour un adolescent déjà diagnostiqué **HPI / TDAH / TOP**, présentant des **difficultés d'expression émotionnelle**, ayant eu tendance à l'isolement dans l'enfance, et étant **l'aîné d'une fratrie de 5**. L'objectif est de préciser le tableau clinique complet : troubles des apprentissages associés (dys), profil TSA possible, impact psychologique, profil affectif et ressources.

A Informations générales

Prénom :

Âge / Date de naissance :

Classe :

Date du questionnaire :

Informateur principal (parent, professionnel) :

Position dans la fratrie

Rang dans la fratrie : ■ Aîné(e) — Nombre total de frères/sœurs : _____

Différences d'âge avec le(s) suivant(s) : _____

Rôle perçu dans la famille (décrit par les parents ou lui-même) :

■ Rôle de parentification repéré

■ Pression liée au rang d'aîné

■ Jalousie / rivalité fraternelle

■ Isolement dans la fratrie

■ Modèle / référence pour les autres

■ Surresponsabilisation

1 Histoire du développement

Grossesse et naissance

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Grossesse sans complication | ☐ Stress maternel important | ☐ Alitement / complication |
| ☐ Naissance à terme | ☐ Prématurité (préciser semaines) | ☐ Complications néonatales |
| ☐ Séjour en néonatalogie | ☐ Hypoxie / souffrance fœtale | ☐ Jaunisse néonatale |

Précisions éventuelles :

Développement moteur

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Marche avant 15 mois | ☐ Marche après 18 mois | ☐ Maladresse motrice précoce |
| ☐ Suivi kiné / psychomotricien | ☐ Difficultés de coordination | ☐ Retard de développement moteur |

Âge approximatif de la marche / commentaires :

Développement du langage

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Premiers mots avant 18 mois | ☐ Premiers mots après 24 mois | ☐ Retard de langage repéré |
| ☐ Suivi orthophonique | ☐ Bégaiement / tics verbaux | ☐ Mutisme sélectif possible |
| ☐ Écholalie observée | ☐ Langage très formel / adulte | |

Âge des premiers mots / âge des premières phrases :

Sommeil

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Endormissement difficile | ☐ Réveils nocturnes fréquents | ☐ Cauchemars / terreurs nocturnes |
| ☐ Somnambulisme | ☐ Hypersomnie | ☐ Insomnie persistante |
| ☐ Résistance au coucher | ☐ Besoin de rituels stricts | |

Heure habituelle du coucher / durée de sommeil :

Santé et antécédents médicaux

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Vue vérifiée — résultat normal | ☐ Trouble visuel non corrigé | ☐ Audition vérifiée — normal |
| ☐ Trouble auditif repéré | ☐ Épilepsie / convulsions | ☐ Maladies chroniques |
| ☐ Traitement en cours | ☐ Hospitalisations importantes | ☐ Douleurs chroniques |

Traitement médicamenteux actuel (molécule + motif) :

2 Troubles des apprentissages (Dys)

Cotation 0 = jamais / non observé · 1 = parfois / léger · 2 = souvent / net · 3 = très souvent / marqué

0	1	2	3
Jamais /	Parfois /	Souvent /	Très souvent /
non observé	léger	net	marqué

2.1 Lecture (repérage dyslexie)

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Lecture lente, laborieuse, coûteuse	■	■	■	■	
Confusions de lettres ou sons proches (b/d, p/q, s/z...)	■	■	■	■	
Sauts de mots, de lignes, inversions de syllabes	■	■	■	■	
Compréhension fragile sur texte long	■	■	■	■	
Lecture à voix haute très hésitante	■	■	■	■	
Fatigue et découragement liés à la lecture	■	■	■	■	
Écart net entre compréhension orale et lecture	■	■	■	■	
Évitement de la lecture	■	■	■	■	

Orientation première intention : Orthophoniste :

2.2 Orthographe et expression écrite (repérage dysorthographe)

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Fautes nombreuses et persistantes malgré l'apprentissage	■	■	■	■	
Oublis de lettres, syllabes, accords fréquents	■	■	■	■	
Niveau oral nettement supérieur à l'écrit	■	■	■	■	
Difficulté à organiser ses idées à l'écrit	■	■	■	■	
Confusions de sons ou de graphèmes persistantes	■	■	■	■	
Copie lente, coûteuse, source d'erreurs	■	■	■	■	
Évitement des tâches d'écriture longue	■	■	■	■	

Les évaluations écrites sous-estiment ses compétences	■	■	■	■	
---	---	---	---	---	--

Orientation première intention : Orthophoniste :

2.3 Écriture et geste graphique (repérage dysgraphie)

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Écriture peu lisible ou illisible	■	■	■	■	
Tenue du stylo crispée ou immature	■	■	■	■	
Fatigue / douleur lors de l'écriture prolongée	■	■	■	■	
Appui excessif ou insuffisant	■	■	■	■	
Écriture excessivement lente	■	■	■	■	
Mise en page désorganisée (marges, lignes)	■	■	■	■	
Qualité qui se dégrade nettement avec la fatigue	■	■	■	■	
Évite d'écrire même s'il connaît la réponse	■	■	■	■	

Orientation première intention : Ergothérapeute / psychomotricien :

2.4 Mathématiques et cognition numérique (repérage dyscalculie)

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Lenteur marquée en calcul écrit ou mental	■	■	■	■	
Tables peu ou pas automatisées	■	■	■	■	
Confusion de nombres, signes, colonnes	■	■	■	■	
Difficulté à résoudre un problème malgré répétition	■	■	■	■	
Mauvaise estimation du résultat attendu	■	■	■	■	
Difficultés avec proportions, unités, temps, argent	■	■	■	■	
Anxiété ou évitement spécifique des maths	■	■	■	■	
Écart important entre efforts et résultats en maths	■	■	■	■	

Orientation première intention : Orthophoniste (cognition mathématique) / neuropsychologue :

2.5 Coordination et motricité (repérage dyspraxie)

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Maladresse persistante dans les gestes quotidiens	■	■	■	■	
Se cogne, renverse, casse fréquemment	■	■	■	■	
Gestes techniques laborieux (ciseaux, compas, règle)	■	■	■	■	
Difficulté à gérer écoute + prise de notes simultanément	■	■	■	■	
Désorganisation marquée de la feuille / mise en page	■	■	■	■	
Difficulté avec géométrie, tracés, repérage spatial	■	■	■	■	
Fatigue ou douleur à l'écriture prolongée	■	■	■	■	
Le geste reste coûteux — automatisation attendue non atteinte	■	■	■	■	

Orientation première intention : Ergothérapeute / psychomotricien :

3 Attention, impulsivité, fonctions exécutives (TDAH — profil détaillé)

Diagnostic TDAH déjà posé. Cette section permet de préciser le profil (inattentif prédominant / hyperactif-impulsif / mixte) et de documenter le retentissement scolaire et quotidien actuel.

3.1 Inattention

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Se distrait facilement (bruits, mouvements, pensées parasites)	■	■	■	■	
Perd le fil de la tâche en cours	■	■	■	■	
Oublie consignes, matériel, échéances	■	■	■	■	
Commence sans finir — nombreuses tâches inachevées	■	■	■	■	
Erreurs d'inattention fréquentes dans le travail	■	■	■	■	
Ne semble pas écouter quand on lui parle directement	■	■	■	■	
Évite les tâches demandant un effort mental soutenu	■	■	■	■	
Très variable selon l'intérêt pour la tâche (hyperfocus vs décrochage)	■	■	■	■	

3.2 Hyperactivité / agitation interne

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Agitation motrice persistante (remue, se tortille, se lève)	■	■	■	■	
Agitation interne décrite par lui-même	■	■	■	■	
Parle excessivement	■	■	■	■	
Difficultés à rester assis pour une tâche cognitive longue	■	■	■	■	
Besoin de bouger pour se concentrer	■	■	■	■	
Sommeil agité, difficulté à se poser en soirée	■	■	■	■	

3.3 Impulsivité

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Répond avant la fin de la question	■	■	■	■	

Coupe la parole fréquemment	■	■	■	■	
Agit avant de réfléchir (décisions rapides, conséquences non mesurées)	■	■	■	■	
Difficulté à attendre son tour	■	■	■	■	
Impulsivité verbale (ce qui pense est dit immédiatement)	■	■	■	■	
Réactions explosives face à la frustration	■	■	■	■	

3.4 Fonctions exécutives

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Difficulté à planifier un travail long ou complexe	■	■	■	■	
Procrastination importante malgré les intentions	■	■	■	■	
Organisation du cartable / bureau très défailante	■	■	■	■	
Difficulté à démarrer une tâche sans étayage	■	■	■	■	
Gestion du temps perturbée (sous-estime la durée)	■	■	■	■	
Difficulté à inhiber les réponses automatiques	■	■	■	■	
Flexibilité mentale faible (résistance aux changements)	■	■	■	■	
Mémoire de travail fragile (perd l'info en chemin)	■	■	■	■	

Synthèse du domaine :

4 Profil TSA et communication sociale (repérage)

Le TDAH et le TSA sont fréquemment associés. Un profil HPI peut masquer des traits autistiques. L'isolement précoce, la préférence pour la solitude et les difficultés d'expression émotionnelle sont des signaux à explorer systématiquement dans ce tableau clinique.

4.1 Communication sociale

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Difficulté à décoder les sous-entendus, l'ironie, l'implicite	■	■	■	■	
Compréhension très littérale des échanges	■	■	■	■	
Décalage social avec les pairs (relation peu ajustée)	■	■	■	■	
Préférence marquée pour les adultes ou les plus jeunes	■	■	■	■	
Isolement ou relations très sélectives	■	■	■	■	
Difficulté à maintenir une conversation réciproque	■	■	■	■	
Échanges centrés sur ses propres intérêts	■	■	■	■	
Incompréhensions sociales fréquentes malgré bonne volonté	■	■	■	■	

4.2 Préférence pour la solitude (depuis l'enfance)

Ce point est particulièrement important dans le profil de ce jeune. La préférence précoce pour la solitude peut indiquer un profil TSA, un trait anxieux d'évitement, un profil hypersensible, ou une combinaison.

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Préférerait jouer seul dans l'enfance	■	■	■	■	
Cherche encore activement la solitude (ressourcement)	■	■	■	■	
Les interactions de groupe sont épuisantes	■	■	■	■	
Fatigue sociale marquée après journées en collectivité	■	■	■	■	
Sentiment d'être "différent" des autres	■	■	■	■	
Difficulté à rejoindre un groupe déjà formé	■	■	■	■	
Jeu symbolique pauvre ou répétitif dans l'enfance	■	■	■	■	

Relations amicales peu nombreuses mais intenses	■	■	■	■	
---	---	---	---	---	--

4.3 Rigidités, routines, intérêts

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Besoin de routines très stables pour fonctionner	■	■	■	■	
Réactions fortes aux changements imprévus	■	■	■	■	
Intérêts spécifiques très absorbants ou exclusifs	■	■	■	■	
Persévérance sur certains sujets (discours difficile à interrompre)	■	■	■	■	
Besoin de prévisibilité dans les consignes et les règles	■	■	■	■	
Difficulté à accepter une règle perçue comme arbitraire ou injuste	■	■	■	■	
Rigidité cognitive — peu de flexibilité face à l'imprévu	■	■	■	■	

4.4 Particularités sensorielles

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Hypersensibilité au bruit (classe, couloirs, foule)	■	■	■	■	
Hypersensibilité aux textures (vêtements, contacts physiques)	■	■	■	■	
Hypersensibilité à la lumière ou aux écrans	■	■	■	■	
Hyposensibilité (cherche les sensations fortes)	■	■	■	■	
Difficultés dans les espaces bruyants ou animés	■	■	■	■	
Évitement des activités physiques de contact	■	■	■	■	
Réactions corporelles atypiques face au stress	■	■	■	■	

Orientation TSA : médecin formé TND, neuropsychologue, équipe spécialisée :

5 Expression émotionnelle et régulation (profil approfondi)

Ce jeune a des difficultés documentées dans l'expression de ses émotions. Cette section explore la nature de ces difficultés : alexithymie possible, inhibition apprise, mécanismes de défense, et impact sur les relations.

5.1 Identification et expression des émotions

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Difficulté à nommer ce qu'il ressent (cherche ses mots)	■	■	■	■	
Confond les émotions entre elles (ex. peur et colère)	■	■	■	■	
Décrit plutôt les sensations physiques que les émotions	■	■	■	■	
Dit "rien" ou "je sais pas" quand on lui demande comment il se sent	■	■	■	■	
Exprime ses émotions surtout par le comportement (pas la parole)	■	■	■	■	
Réponse émotionnelle retardée (comprend après coup ce qu'il ressentait)	■	■	■	■	
Émotions très intenses mais peu verbalisées	■	■	■	■	
Masque ses émotions (paraît calme alors qu'il est en souffrance)	■	■	■	■	

5.2 Régulation émotionnelle

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Explose vite face à la frustration ou à l'injustice perçue	■	■	■	■	
Difficulté à redescendre après une montée émotionnelle	■	■	■	■	
Ruminations fréquentes (rejoue mentalement les événements)	■	■	■	■	
Temps de récupération long après une contrariété	■	■	■	■	
Réaction émotionnelle disproportionnée au stimulus apparent	■	■	■	■	
Utilise l'humour ou la provocation pour masquer une émotion	■	■	■	■	
Se ferme, s'isole ou se mure dans le silence	■	■	■	■	

S'automédique (écrans, bouger, manger) pour réguler	☒	☒	☒	☒	
---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

5.3 Sensibilité à l'injustice (spécifique HPI/TOP)

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Réagit très fortement à ce qu'il perçoit comme injuste	☒	☒	☒	☒	
Argumentation très développée pour contester une règle	☒	☒	☒	☒	
Sentiment récurrent d'être traité différemment des autres	☒	☒	☒	☒	
Difficulté à lâcher quand il pense avoir raison	☒	☒	☒	☒	
Cherche à tout prix à avoir le dernier mot	☒	☒	☒	☒	
Opposition nette quand une consigne n'est pas justifiée	☒	☒	☒	☒	

5.4 Anxiété

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Anxiété de performance (surtout avant les évaluations)	☒	☒	☒	☒	
Somatisation (maux de ventre, de tête avant l'école)	☒	☒	☒	☒	
Ruminations la nuit ou le soir	☒	☒	☒	☒	
Peur du jugement / du regard des autres	☒	☒	☒	☒	
Anxiété sociale (interactions, nouveaux contextes)	☒	☒	☒	☒	
Évitement de situations générant de l'incertitude	☒	☒	☒	☒	
Perfectionnisme ou peur majeure de l'échec	☒	☒	☒	☒	

Synthèse du domaine :

6 Profil psychologique et estime de soi

6.1 Estime de soi

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Se dévalorise fréquemment ("je suis nul", "j'y arriverai jamais")	■	■	■	■	
Vécu d'échec scolaire répété et intériorisé	■	■	■	■	
Image de soi défensive : préfère passer pour insolent que pour faible	■	■	■	■	
Comparaison défavorable avec les autres	■	■	■	■	
Besoin fort d'être reconnu / valorisé	■	■	■	■	
Difficulté à recevoir un compliment sans le minimiser	■	■	■	■	
Sentiment d'imposture malgré des capacités élevées	■	■	■	■	

6.2 Harcèlement scolaire (histoire)

Un vécu de harcèlement laisse des traces durables sur la posture défensive, l'hypervigilance sociale et la régulation émotionnelle. Il est essentiel de bien documenter cet historique.

Période(s) concernée(s) — âge / classe :

Nature du harcèlement (verbal, physique, social, numérique) :

Prise en charge de l'époque (école, famille, professionnels) :

■ Hypervigilance sociale persistante

■ Posture défensive systématique

■ Méfiance vis-à-vis des pairs

■ Méfiance vis-à-vis des adultes

■ Réactions disproportionnées à la moquerie

■ Évitement des contextes de groupe

6.3 Dépression / retrait

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Perte de plaisir pour des activités autrefois appréciées	■	■	■	■	
Fatigue chronique non liée au sommeil	■	■	■	■	

Retrait relationnel progressif	■	■	■	■	
Dévalorisation persistante	■	■	■	■	
Pensées sombres exprimées ou supposées	■	■	■	■	
Difficultés à se projeter dans l'avenir	■	■	■	■	

6.4 Comportements externalisés (TOP — profil détaillé)

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Désobéissance active et répétée aux adultes de référence	■	■	■	■	
Discussions ou contestations fréquentes des règles	■	■	■	■	
Cherche délibérément à contrarier ou agacer les autres	■	■	■	■	
Fait porter la responsabilité de ses erreurs sur autrui	■	■	■	■	
Irritabilité fréquente, susceptibilité	■	■	■	■	
Comportement vengeur ou rancunier	■	■	■	■	
Différence notable selon le contexte (maison vs école vs extérieur)	■	■	■	■	
Présence dans plusieurs contextes depuis plus de 6 mois	■	■	■	■	

Synthèse du domaine :

7 Contexte familial et événements de vie

7.1 Dynamique familiale

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Famille unie | ☐ Séparation / divorce | ☐ Famille recomposée |
| ☐ Deuil récent | ☐ Déménagement(s) | ☐ Changements d'école fréquents |
| ☐ Difficultés économiques | ☐ Isolement géographique ou social de la famille | |

Description de la dynamique actuelle à la maison :

7.2 Relation parents / enfant

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Relation chaleureuse et sécurisante	☐	☐	☐	☐	
Conflit fréquent avec un ou les deux parents	☐	☐	☐	☐	
Communication difficile — peu d'échanges verbaux	☐	☐	☐	☐	
Parent(s) lui-même(s) présentant des traits TND repérés	☐	☐	☐	☐	
Pression liée aux attentes scolaires ou sociales	☐	☐	☐	☐	
Charge pesant sur lui en lien avec son rang d'aîné	☐	☐	☐	☐	

Antécédents familiaux de TND (TDAH, dys, TSA, TOP) :

7.3 Événements marquants

Y a-t-il eu des événements difficiles ces dernières années ? (préciser) :

7.4 Ressources et points d'appui

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Adulte référent à l'école | ☐ Suivi psychologique en cours | ☐ Suivi orthophonique |
| ☐ Suivi psychomotricien | ☐ Suivi médical (pédiatre / neuropédiatre) | ☐ Soutien familial stable |
| ☐ Activité sportive régulière | ☐ Activité artistique / créative | ☐ Hobby / passion structurante |

■ Pairs compréhensifs

8 Parcours scolaire détaillé

Établissements fréquentés (liste + classes) :

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Redoublement (préciser) | ☐ Saut de classe | ☐ Changement d'école fréquent |
| ☐ ULIS / SEGPA | ☐ PAP en cours | ☐ PPS en cours |
| ☐ PPRE en cours | ☐ Aucun aménagement formalisé | |

Comment les enseignants le décrivent-ils (mots récurrents dans les bulletins) :

Relations avec les camarades de classe :

Domaines scolaires où il est le plus à l'aise :

Domaines scolaires les plus difficiles :

Devoirs et travail à la maison

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Se met au travail seul | ☐ A besoin de relances répétées | ☐ Blocage / pleurs / refus |
| ☐ Crises régulières lors des devoirs | ☐ Dur à démarrer mais continue ensuite | ☐ Abandonne rapidement |
| ☐ Besoin d'un adulte présent tout le long | ☐ Durée des devoirs anormalement longue | |

9 Profil HPI — caractéristiques détaillées

Le HPI n'est pas un TND. Il peut coexister avec un TND (profil "doublement exceptionnel" ou 2e), le masquer ou compliquer le repérage. Dans ce profil HPI + TDAH + TOP, le HPI peut amplifier l'injustice perçue, l'ennui, la surcharge émotionnelle et la résistance à l'autorité. Il peut aussi masquer des dys ou un TSA pendant des années.

9.1 Fonctionnement cognitif HPI

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Pensée rapide, arborescente — passe d'une idée à l'autre très vite	■	■	■	■	
Fait des connexions inattendues entre des concepts éloignés	■	■	■	■	
Comprend très vite quand quelque chose l'intéresse	■	■	■	■	
Pose des questions complexes, philosophiques ou inattendues pour son âge	■	■	■	■	
Raisonnement par hypothèses — anticipe, extrapole, généralise	■	■	■	■	
Mémoire sélective forte (retient ce qui l'intéresse, oublie le reste)	■	■	■	■	
Décalage important entre pensée rapide à l'oral et production écrite	■	■	■	■	
Grand besoin de sens — refuse les apprentissages mécaniques sans justification	■	■	■	■	

9.2 Relation à l'autorité et aux règles

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Remet en question les règles qu'il juge arbitraires ou injustes	■	■	■	■	
Cherche à comprendre le pourquoi avant d'obéir	■	■	■	■	
Résiste à l'autorité non légitime à ses yeux	■	■	■	■	
Haut niveau d'argumentation pour contester une décision	■	■	■	■	
Opposition plus marquée avec les adultes qu'il ne respecte pas intellectuellement	■	■	■	■	
Peut accepter l'autorité d'un adulte reconnu comme compétent et juste	■	■	■	■	
Difficulté à accepter un "non" sans explication	■	■	■	■	

Cherche délibérément la faille dans le raisonnement de l'adulte	☒	☒	☒	☒	
---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

9.3 Relation à l'ennui et à la motivation

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Décroche très vite des tâches répétitives ou peu stimulantes	☒	☒	☒	☒	
L'ennui en classe génère de l'agitation ou de la perturbation	☒	☒	☒	☒	
Motivation très variable selon l'intérêt pour le sujet	☒	☒	☒	☒	
Peut produire un travail excellent sur ce qui le passionne	☒	☒	☒	☒	
Alternance brutale : surinvestissement / désengagement total	☒	☒	☒	☒	
Perfectionnisme sur ce qui l'intéresse / bâcle ce qui l'ennuie	☒	☒	☒	☒	
Sensible à la qualité de la relation avec l'enseignant	☒	☒	☒	☒	
Peut simuler l'incompréhension pour éviter une tâche ennuyeuse	☒	☒	☒	☒	

9.4 Hypersensibilité émotionnelle et sensorielle

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Ressent les émotions de manière très intense	■	■	■	■	
Forte empathie — absorbe les émotions des autres	■	■	■	■	
Se sent facilement submergé émotionnellement	■	■	■	■	
Hypersensibilité à l'injustice (pour lui et pour les autres)	■	■	■	■	
Réagit fortement aux critiques, même légères	■	■	■	■	
Sens aigu des inégalités, de la souffrance d'autrui	■	■	■	■	
Fatigue émotionnelle importante après des journées intenses	■	■	■	■	
Particularités sensorielles possibles (bruit, lumière, textures)	■	■	■	■	

9.5 Profil social et sentiment d'être différent

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Sentiment profond d'être incompris par les pairs	■	■	■	■	
Préfère les adultes ou les plus âgés comme interlocuteurs	■	■	■	■	
Relations sociales peu nombreuses mais très intenses	■	■	■	■	
Discours qui peut paraître "donneur de leçons" involontairement	■	■	■	■	
Humour décalé, second degré que les pairs ne comprennent pas toujours	■	■	■	■	
Sentiment de solitude intellectuelle même entouré	■	■	■	■	
Difficulté à masquer son niveau pour "rentre dans le moule"	■	■	■	■	
Peut être perçu comme arrogant alors qu'il exprime simplement ce qu'il pense	■	■	■	■	

9.6 Profil doublement exceptionnel — HPI + TDAH (spécifique)

Le profil "doublement exceptionnel" (2e) est fréquemment sous-repéré. Le HPI peut masquer le TDAH (et inversement). Les capacités compensent les déficits pendant un temps — jusqu'à ce que la charge cognitive dépasse les ressources. Le résultat est souvent un profil qui "passe" à l'école primaire et décompense au collège ou au lycée.

Indicateur	0	1	2	3	Observations
Le HPI a compensé le TDAH pendant des années — puis décompensation progressive	■	■	■	■	
Paraît moins touché que ce qu'il est réellement grâce à son intelligence	■	■	■	■	
Les résultats scolaires ne reflètent pas les difficultés réelles	■	■	■	■	
Épuisement cognitif important — compenser coûte énormément d'énergie	■	■	■	■	
Les bilans standard peuvent sous-estimer les difficultés	■	■	■	■	
Frustration de ne pas être compris ni dans ses forces ni dans ses fragilités	■	■	■	■	
Image de soi clivée : "je suis doué" vs "je suis nul / paresseux"	■	■	■	■	
Grande souffrance devant l'écart perçu entre son potentiel et ses résultats	■	■	■	■	

9.7 Ressources et points d'appui liés au HPI

- Capacité d'abstraction élevée ■ Créativité et originalité ■ Vitesse de compréhension
- Sens de l'humour ■ Empathie et altruisme ■ Capacité d'analyse critique
- Passions structurantes ■ Mémoire sélective forte ■ Sens de la justice mobilisable
- Curiosité intellectuelle ■ Leadership naturel ■ Ténacité sur ses centres d'intérêt

Centres d'intérêt forts / domaines de passion identifiés :

Note clinique : Le HPI est une ressource. L'enjeu est de s'appuyer sur ses forces pour construire des outils adaptés à ses fragilités. :

1
0

Synthèse clinique et orientation

Domaine	Signes repérés	Niveau de priorité	Orientation
Lecture / Dyslexie		■ Faible ■ Modéré ■ Fort	Orthophoniste
Orthographe / Dysorthographie		■ Faible ■ Modéré ■ Fort	Orthophoniste
Écriture / Dysgraphie		■ Faible ■ Modéré ■ Fort	Ergo / Psychomotricien
Maths / Dyscalculie		■ Faible ■ Modéré ■ Fort	Orthophoniste / Neuropsychologue
Coordination / Dyspraxie		■ Faible ■ Modéré ■ Fort	Ergo / Psychomotricien
TDAH — profil détaillé		■ Faible ■ Modéré ■ Fort	Médecin / Neuropsychologue
Profil TSA à explorer		■ Faible ■ Modéré ■ Fort	Médecin TND / Équipe spécialisée
Émotions / Alexithymie		■ Faible ■ Modéré ■ Fort	Psychologue / TCC
Estime de soi / Dépression		■ Faible ■ Modéré ■ Fort	Psychologue / Pédopsychiatre
TOP — retentissement		■ Faible ■ Modéré ■ Fort	Pédopsychiatre / Psychologue
Contexte familial		■ Faible ■ Modéré ■ Fort	Guidance parentale

Questions de synthèse obligatoires

Question	Oui	Non	Partiel
Les difficultés durent depuis plus de 6 mois ?	■	■	■
Présentes dans plusieurs contextes (maison, école, social) ?	■	■	■
Plus marquées que chez les pairs du même âge ?	■	■	■
Résistent à l'aide ordinaire et aux explications répétées ?	■	■	■
Retentissement sur la scolarité, l'autonomie ou les relations ?	■	■	■
Antécédents familiaux de TND ?	■	■	■

Facteurs alternatifs recherchés (vision, audition, anxiété, sommeil...) ?			
---	---	---	---



Domaines les plus touchés :

Professionnels à solliciter en priorité :

Adaptations immédiates proposées :

Commentaires / observations cliniques complémentaires :

Haddouch Nawel

Neuropédagogue / Coach spécialisée TND

Cabinet Educa Typique

Date :